

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DİJİTALLEŞME VE SOSYAL MEDYA



İÇİNDEKİLER

- Sağlık
- Sağlığın Geliştirilmesi
- Sağlık ve Kitle İletişim Araçları
- Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme
- Sağlık İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi konusunda kavramsal bir beceriye sahip olabilecek,
- Kitle iletişim araçlarını sağlık iletişimi bağlamında değerlendirebilecek,
- Sağlığın dijitalleşmesinin sağlık iletişimi açısından önemini kavrayabilecek,
- Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımının avantaj ve risklerini değerlendirebileceksiniz.

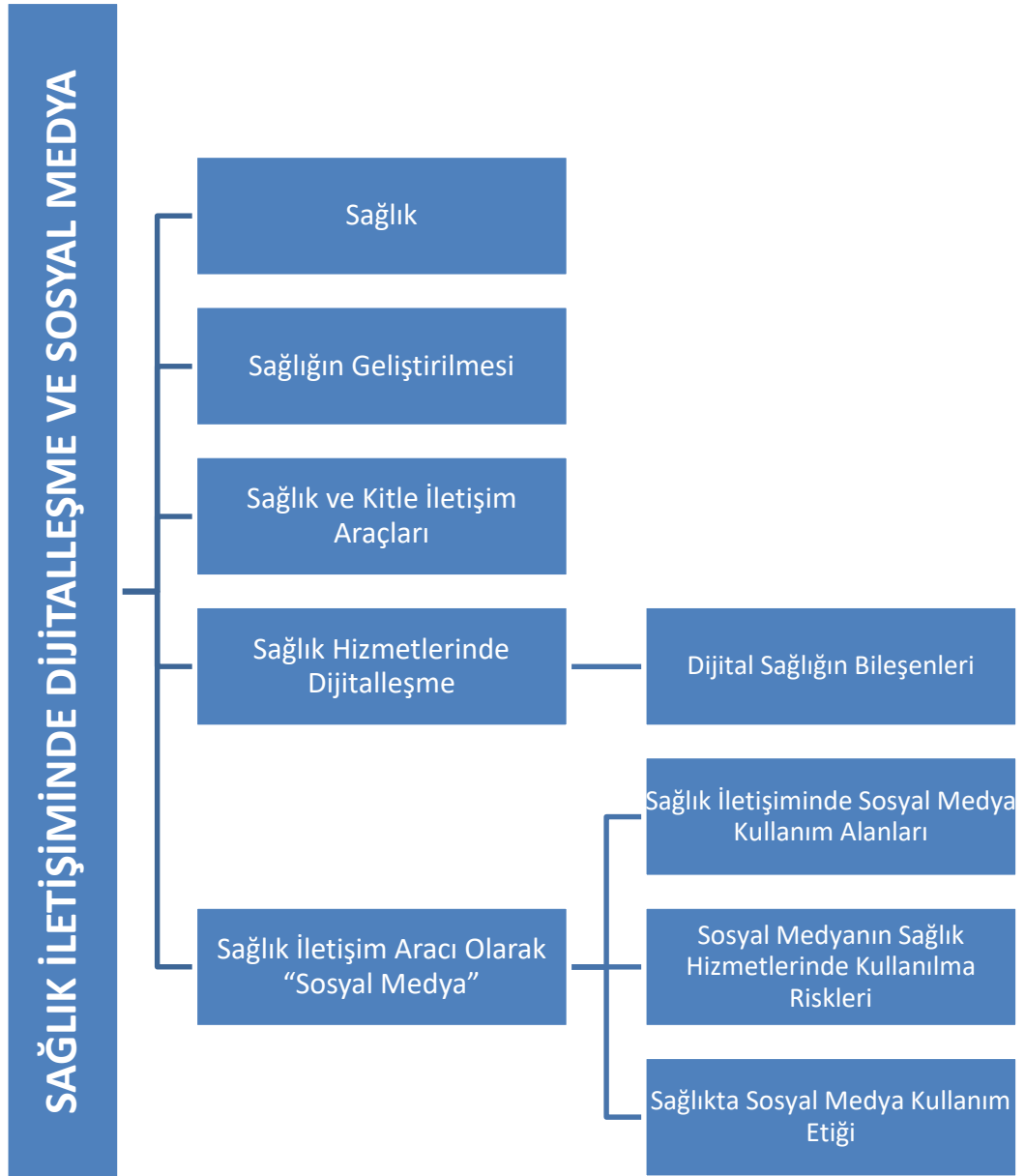


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

DİJİTAL KÜLTÜR VE SOSYAL MEDYA

Prof. Dr.
Hasan GÜLLÜPUNAR

ÜNİTE
10



GİRİŞ

Teknolojinin gelişimi insanın doğaya karşı zayıflıklarının üstesinden gelme mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Teknoloji bir taraftan insanın günlük hayattaki zayıflıklarına bir çare iken diğer taraftan konforunu artıran bir unsurdur. İnsanın günlük yaşamında hem zayıflıklarının üstesinden gelme hem de konforunu artırmaya çalıştığı alanlardan biri sağlıktır. İnsanın sosyal, kültürel, ekonomik ve ruhsal bakımdan çok geniş bir alandaki mutluluğu sağlığıyla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla sağlıklı olma isteği bireyin en önemli önceliklerinden biridir.



Sağlığın dijitalleşmesi bireyin sağlık konusunda zayıflıklarının üstesinden gelmesi ve sağlıklı yaşam adına konforunun artması için avantaj sağlayan bir gelişme olmuştur.

Sağlığın dijitalleşmesi bireyin sağlık konusunda zayıflıklarının üstesinden gelmesi ve sağlıklı yaşam adına konforunun artması için oldukça avantaj sağlayan bir gelişme olmuştur. Sağlıkta dijitalleşme hem tedavi araç ve yöntemleriyle hem de bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili bir süreçtir. Hastalıkların tedavi edilmesinde ve sağlıklı yaşamın korunmasında teknolojinin gelişmesi inceleme, teşhis ve tedavi yöntemlerinin dijital araçlarla yapılmasını sağlamaktadır. Bu da teşhis ve tedavilerin elektronik süreçlerle daha hassas ölçümlerle gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Bu çalışmada ele alınan dijitalleşme bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgilidir. Sağlık hizmetleri alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri sağlık hizmetlerinin yönetiminden sağlık personelleri arası iletişime; doktor hasta iletişiminden hastalar arasındaki etkileşime; hastalıkların tedavi edilmesinden sağlığın geliştirilmesi konusuna kadar geniş bir alanı etkilemektedir. Dolayısıyla sağlıkta dijitalleşme sağlıkla ilgili belirsizliklerini tanımlamaya çalışan insanın bilgi açığını önemli ölçüde giderecek faydalar sağlamaktadır. Her ne kadar insanın sağlığıyla ilgili kaygı boyutunu artırdığı durumlar olsa da, bu kaygılarına cevap aradığı alan yine çoğunlukla dijital ortamlardır. Bu bağlamda internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısının yediden yetmişe neredeyse bütün topluma yayıldığı sosyal medya, yaygın bir iletişim aracına dönüşmüştür. Etkileşimli yapısıyla bireyin sağlığıyla ilgili bilgilere ya da birçok deneyime ulaştığı önemli iletişim mecralarından biridir. Bu bakımdan bu bölümde dijital kültür ve iletişim açısından önemli bir alan olarak değerlendirilebilecek sağlık konusu dijitalleşme ve sosyal ağlar boyutu ile ele alınmaktadır.

SAĞLIK

Sağlık kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat ve afiyet” olarak tanımlanmaktadır (<http://sozluk.gov.tr>). Sağlık kavramı etimolojik yapısı açısından “sağ olmak”, “hayatta olmak” kökenlerinden gelmekte ve bireyin bütün olarak iyilik halini göstermektedir (Akt. Kumbasar,2012).

Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğünde sağlık, *yalnızca hastalık veya sakatlıkla ilgili olmayıp bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumunu, fonksiyonel terimlerle sonuca ulaşma aracını ve insanların bireysel, sosyal ve ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmesine izin veren bir kaynağı ifade etmektedir* (sbu.saglik.gov.tr). Diğer

bir ifadeyle sağlık, yaşam için bir amaç olarak ele alınmayıp, günlük yaşantıda bir kaynak, fiziksel yetenek, sosyal ve bireysel kaynaklar şeklinde vurgulamaktadır (Kabasakal, 2013)

Sağlıkla ilgili yapılan tanımlar kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Çünkü yapılan tanımlar bireysel, sosyal, kültürel ve ekonomik yorumların birer öznesi durumundadır (Çınar, 2004). Sağlığın kavramsal olarak taşıdığı anlam toplumun üretim geleneğinden tüketim alışkanlıklarına ve sahip olduğu refaha kadar birçok faktörün etkisi altındadır. Dolayısıyla sağlık sadece fiziki ya da ruhsal bir rahatsızlığı değil aynı zamanda olumlu, verimli ve kaliteli bir yaşama sahip olmayı gerektiren bir olgudur. Sağlıklı bireylerin ya da sağlıklı toplumların oluşmasında psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik birçok faktörün etkisi vardır. Bu bağlamda akla gelebilecek en önemli etkenlerden birinin ise toplumun iletişim yapısı ve sahip olduğu iletişim araçları olduğu söylenebilir.

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Sağlığı geliştirme kavramının temelinde; bireyin potansiyelini ve enerjisini kullanma, doyurucu bir yaşam sürdürme, üretken olabilme, sağlık konusunda yeteneklerini sonuna kadar kullanabilme olanağına sahip olma durumu yer almaktadır (Akt. On, 2016).

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi sosyal ve politik bakımdan kapsamlı bir süreçtir. Yalnızca bireylerin beceri ve kapasitesini artırmaya yönelik eylemleri değil, aynı zamanda sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları da değiştirmeye ve böylece bunların toplumun ve bireyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik eylemleri kapsamaktadır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, insanların sağlıklarının belirleyicileri üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve böylece kendi sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir (sbu.saglik.gov.tr).

Sağlığın geliştirilmesi kavramı daha çok önleyici sağlık hizmetlerini kapsayan bir süreci tanımlamaktadır. Bireylerin fiziki ya da ruhsal bir hastalıkla karşılaşmalarını önlemenin yanında mevcut potansiyellerini ve becerilerini en üst seviyede kullanabilmelerini sağlayacak önlemleri geliştirmeyi içermektedir.

Dolayısıyla *sağlığın geliştirilmesi kavramı dinamik bir toplum yapısı oluşturulabilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, yasal ve teknolojik anlamda geniş bir alanı kapsamaktadır.*

Ottawa Sözleşmesi'nde sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik üç temel strateji belirlenmiştir. Bunlar, sağlığın desteklenmesi; insanların tam sağlık potansiyellerine erişmelerinin sağlanması ve sağlık arayışında toplumdaki farklı çıkarlar arasında arabuluculuk yapılmasından oluşmaktadır (sbu.saglik.gov.tr). Bu kapsamda toplumun sağlığının geliştirilmesi için politikaların belirlenmesine, bireylerin sağlık potansiyellerini artıracak eğitimlerinin sağlanmasına ve üretim ve tüketim süreçlerinde olduğu gibi toplumun farklı tarafları arasında sağlığın geliştirilmesi konusunda ortak bir bilincin oluşturulmasına dönük eylemlerde bulunulması gerekmektedir. Dolayısıyla uygulamada sağlığın geliştirilmesi ismi geniş bir alan için kullanılmaktadır. Örneğin Downie ve arkadaşları sağlığın



Sağlığın geliştirilmesi kavramı, potansiyel ve enerjiyi kullanma, doyurucu yaşam, üretkenlik ve sağlık yeteneklerinin sonuna kadar kullanılabilme olanağı temeline dayanmaktadır.

geliştirilmesi aktiviteleri için yedi farklı alan tanımlamışlardır. Bunlar (Rootman vd. 2001):

- Koruyucu hizmetler (bağışıklık kazandırma, rahim taraması, hipertansiyon vaka bulma, nikotin içeren sakız sağlama gibi)
- Koruyucu sağlık eğitimi (yaşam tarzını etkileme ve önleyici hizmetlerden yararlanmayı artırma çabaları gibi)
- Önleyici sağlık tedbirleri (suyun florlanması gibi)
- Önleyici sağlık tedbirleri için sağlık eğitimi (emniyet kemeri mevzuatı için lobi faaliyetinde bulunma gibi)
- Pozitif sağlık eğitimi (sağlık alanındaki davranışları olumlu bir şekilde etkilemeyi, boş zamanın verimli bir şekilde kullanılmasının teşvikini ve insanların sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesini amaçlamak gibi)
- Pozitif sağlık tedbirleri (iş yerinde sigara içmeme politikasının uygulanması ve boş zaman imkânlarının sunulması gibi)
- Pozitif sağlık tedbirleri için sağlık eğitimi (sağlığın geliştirilmesi tedbirleri için destek almak gibi)



Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi çabasında süreklilik için katılım esastır. Halkın katılımını teşvik eden girişimler sağlığın geliştirilmesi sürecinde oldukça önemlidir.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi çabasında süreklilik için katılım esastır (sbu.saglik.gov.tr). Bir girişimin sağlığı geliştirici olup olmadığına karar vermek için öncelikli kriter; bu süreçte bireylerin veya toplulukların ne kadar yetkilendirildiği veya ne kadar etkin kılındığı sorularına verilecek cevaptır. Bu bakımdan halkın katılımını teşvik eden girişimler sağlığın geliştirilmesi süreci açısından oldukça önemlidir (Kabasakal, 2013). Katılımın sağlanması iletişim teknolojileriyle yakından ilişkilidir. *İki yönlü ve özellikle interaktif iletişim imkânı veren araçların kullanımı katılım düzeyini ve etkinliğini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla sağlığın dijitalleşmesi yalnızca bir hastalık nedeniyle sağlık hizmeti alanlarla iletişimin sağlanması değil aynı zamanda sağlığın geliştirilmesi politikaları açısından da önemlidir.*

SAĞLIK VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Kitle iletişimi, kitlesel düzeyde, bütün bir topluma ilişkin olarak gerçekleşen bir iletişimdir. Çoğunlukla kitle iletişim araçlarına dayalı olarak tanımlansa da kitle iletişim aracı olmadan da mitingler, stadyumlardaki etkinlikler gibi toplantılarda kitle iletişimi gerçekleştirilebilmektedir (Güngör, 2011a).

Yapılan araştırmalar sosyalleşme ve toplumdaki egemen ideolojinin bireylere aktarılmasında kitle iletişim araçlarının oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bireyler gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla aynı anda çok sayıda insana ulaşarak onların tutum ve davranışlarını, duygu ve düşüncelerini değiştirmeye çalışmaktadırlar (Tosyalı ve Sütçü, 2016). Aynı zamanda başkalarının kitle iletişim araçlarıyla yayılan tutum, davranış, görüş ve düşüncelerinden de etkilenmektedirler.

Kitle iletişim araçları toplumsal değişim ve dönüşüm açısından oldukça önemli etkilere sahiptir. Özellikle yeni bir durumun topluma anlatılmasında kitle iletişim araçları önemli bir aktördür. Bu anlamda kitle iletişim araçlarının

yeniliklerin topluma yayılması ve yerleşmesi ile ilgili aşamaları Rogers şu şekilde ortaya koymuştur (Güngör, 2011b):

- **Bilgilendirme:** İnsanların yenilik hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
- **İkna:** Yenilikler hakkında gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra söz konusu yenilikle ilgili bir tutumun geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tutum eskinin unutturularak yeniyi ilişkin olumlu algıların oluşmasını sağlamaktır.
- **Karar:** Bilgilendirme ve ikna işleminden sonra bireyin yeni olana ilişkin bir karar vermesi beklenir. Bu kararın verilmesi sürecinde kitle iletişim araçlarının etkisi önemlidir.
- **Onaylama:** Birey verdiği kararın çevresi tarafından onaylanmasını bekler. Dolayısıyla bu onaylamada da kitle iletişim araçlarının önemli etkileri vardır.



Kitle iletişim araçları sağlık konusunda bireyin güdülenmesini, olumlu sağlık davranışının pekiştirilmesini, sağlık hizmetlerine talep oluşturulmasını ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayabilir.

Herhangi bir konuda tutum ve davranışın oluşabilmesi için bilgilendirme, ikna, karar ve onaylama aşamalarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sağlık iletişimi açısından kitle iletişim araçlarının bilgilendirme, ikna, karar ve onay aşamasındaki fonksiyonu önemlidir. Özellikle sağlığın geliştirilmesi bağlamında geliştirilecek politikaların toplumsal bir kabule ulaşabilmesi için kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Sağlık alanında toplumsal bir farkındalık ve duyarlılık oluşturabilmek, kitle iletişim araçlarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla yakından ilgilidir. Örneğin son yıllarda yapılan televizyon programları toplumun şeker tüketimi konusundaki duyarlılığını artırmış ve bu konuda yeni bir tutum oluşturmuştur.

Sağlık sorunlarında kitle iletişim araçları kullanılarak bireyin istenilen davranışa güdülenmesi, mevcut olumlu sağlık davranışının pekiştirilmesi, sağlık hizmetlerine talep oluşturulması ve hizmet kalitesinin artırılması sağlanabilir. Bu anlamda etkili kitle iletişim araçlarından biri televizyondur. Türkiye’de ulusal alanda yayın yapan televizyon kanallarının programları içinde sağlıkla ilgili programlar hem sayısı hem de süresi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu programlar çoğunlukla hafta içi günlerde yayımlanmaktadır. Gündüz saatlerinde yayımlanan bu programlar genellikle 50 yaş ve üzerindeki kadın izleyiciler tarafından yoğun olarak tüketilmektedir (Koçak ve Bulduklu 2010).

Kişilerin kitle iletişim araçlarına ulaşmasında ve bunları kullanmasında eğitim, yaş ve gelir gibi sosyo-demografik özellikler etkilidir. Ancak sağlıkla ilgili bilgileri yayımlanan programdan alma ve bunların doğruluğuna inanma, medya ile ilgili algılar tarafından etkilenmektedir. Burada kişinin sağlık durumu ve medya aracıyla ilgili algısı önemli bir role sahiptir. Sağlık bilgisinin nerede, nasıl, kim tarafından verildiğinin önemi yoktur. Kişi o an ihtiyacı olan bilgiyi seçmekte, bu bilgileri algı sürecinden geçirmekte, çoğunlukla başka yerde verilen bilgilerle doğruluğunu teyit etmekte ve doğruluğuna inandığında da bu tavsiyeleri davranışa dönüştürmektedir (Avcı ve Avşar, 2014). Dolayısıyla Rogers’ın kitle iletişim araçlarının etkileri konusundaki yeniliklerin yayılması aşamaları önemli ölçüde gerçekleşmiş olmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME

Etkin ve verimli bir sağlık hizmeti verebilmenin temel koşullarından birinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak olduğu söylenebilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiği nokta yeni bir sağlık hizmeti örgütlenmesine olan ihtiyacı artırmıştır. Günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri, bu ihtiyacın sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi olduğunu göstermektedir. Sağlık hizmetinde dijitalleşme verilerini elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması sürecinde sağlık bilgi sistemlerine odaklanmayı gerektirmektedir (Avaner ve Fedai, 2017).



Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme, verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması sürecinde sağlık bilgi sistemlerine odaklanmayı gerektirmektedir.

Her geçen gün insanlar teknolojiye daha kolay ulaşır hale gelmekte ve sağlık konusunda daha hızlı ve nitelikli bir hizmet sürecine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacın karşılanması açısından sağlıkta dijitalleşme sağlık sektörü için şu faydaları sağlamaktadır:

- Sağlıkta dijitalleşme sağlık hizmetlerinin kalite ve verimini artırmakta,
- Vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşmasını ve işlemlerini kendi eliyle gerçekleştirmesini kolaylaştırmakta,
- Oluşturulan veri bankaları ile sağlık politikalarının belirlenmesine katkı yapmakta,
- Sağlık hizmeti sürecinde tasarruf sağlamakta,
- Hem idari işlemler hem de sağlık hizmetinin veriliş süreçleri açısından şeffaflaşma sağlanmakta,
- Sağlığın geliştirilmesi politikaları bakımından katılımı desteklemektedir.

Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi karar destek süreçlerine katılım açısından sağlıkla ilgili kurumların eş güdümünü kolaylaştırmaktadır. Ancak sağlık alanındaki dijitalleşmenin daha görünür faydası vatandaşların sağlık bilgilerine erişimini kolaylaştırmış olmasıdır (Avaner ve Fedai, 2017). Ayrıca sağlığın dijitalleşmesi, sağlık personeli verimliliğini artırmaktadır (Peker vd.2018). Örneğin dijital uygulamalar, hastane iç iletişimde şu faydaları sağlamaktadır (Akt. Danayiyen vd. 2007):

- Zaman kaybı azalmakta ve birim çalışma zamanında daha çok hastaya hizmet verilebilmektedir.
- Hekimler daha verimli kullanılarak hekim açığının kapatılmasına katkı sağlamaktadır.
- Personelin kurum içi hareket özgürlüğü nedeniyle zaman ve iş gücü kaybindan doğan sosyal maliyetler azalmaktadır.
- Etkili bir kurum içi iletişim planlama, uyumlaştırma, karar verme, güdüleme ve denetim sağlamaktadır.
- İş akış ve işleyişler tanımlanmakta, her bir çalışan yetki ve sorumluluklarını öğrenmekte, motivasyonu artmakta, kendinden beklenenleri kavramakta ve çalışanların da üst yönetime beklenti ve isteklerini iletmesine imkân vermektedir.

Türkiye’de sağlıkta dijitalleşmenin en önemli adımının Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi’nin oluşturulması olduğu söylenebilir. 2004’te Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı; veri sözlüğü ve standartlar, tek numaraya dayanan kişisel sağlık tanımlayıcısı, sağlık veri modeli ve minimum sağlık veri setleri, kayıtların gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, erken uyarı sistemleri, sağlık özel ağı, Tele tıp ve eğitim başlıklarından oluşmuştur. Bu başlıklar kapsamında şu eylemler benimsenmiştir:

- Ulusal ve uluslararası uyumu sağlamak amacıyla standartların belirlenmesi,
- Kişinin doğumundan itibaren ölümüne kadar hiç değişmeyecek bir şekilde kişiye onu tanıtıcı bir numaranın tanımlanması,
- Kayıtlara bağlı olarak sağlık sektörünün ihtiyacı olan sağlık veri setlerinin oluşturulması,
- Yazılı ya da elektronik ortamda sağlıkla ilgili kişisel verilerin mahremiyetinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması,
- Sağlık tehditlerinin erken teşhisi ve tedbiri için erken uyarı sistemlerinin oluşturulması,
- Sağlıkla ilgili kuruluşlar arasında gerçekleşecek iletişim ve işlemler için özel ağ oluşturulması,
- Yönetim, eğitim, araştırma, yerinde bakım hizmeti gibi durumlarda sağlık hizmetine erişimde sorun yaşayan bölgeler için ve afet durumlarında gerçekleşecek sağlık hizmetine ulaşamama sorunu için elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması,
- Mezuniyet öncesi sağlık eğitiminde bilgi teknolojilerine yer verilmesi.

Türkiye’de sağlığın dijitalleşmesi adına gerçekleştirilen e-sağlık hizmetleri devletten devlete, devletten iş dünyasına ve devletten vatandaşa olarak gruplandırılabilir. Bu bağlamda (Çiçek ve Söğüt, 2018):

Devletten devlete sunulan e- sağlık hizmetleri; Sağlık-Net, Medikal Ulak (MEDULA), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), İlaç Takip Sistemi (İTS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) – E-İmza, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM), Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS), E-Reçete ve diğer bilgi sistemleridir.

Devletten iş dünyasına olan e-sağlık hizmetleri; İhale ve Alım İlanları, Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi (KTS) ve diğer web hizmetleridir.

Devletten vatandaşa olan e-sağlık hizmetleri; E-Nabız Sistemi, Tele-tıp, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Laboratuvar, Hasta Hakları Şikâyet Başvurusu ve diğer web hizmetleridir.

Dijital Sağlığın Bileşenleri

Tıp ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dijital sağlık kavramının farklı kapsamlarda tanımlanmasına neden olmaktadır. Örneğin dijital sağlık denildiğinde tedavi araç ve yöntemlerindeki dijitalleşme anlaşılacağı gibi bilgi ve iletişim



Türkiye’deki e-sağlık hizmetleri devletten devlete, devletten iş dünyasına ve devletten vatandaşa olmak üzere üç başlıkta gruplandırılabilir.

teknolojilerinin kullanımına dayalı hizmet süreçlerinin dijitalleşmesi de anlaşılabilmektedir. Bu çalışmada kastedilen dijitalleşme kavramı sağlıkta kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı bir dijitalleşmedir. Yani sağlık hizmet süreçleriyle ilgili bir dijitalleşmeyi kapsamaktadır. Bu bakımdan dijital sağlığın bileşenleri başlığı altında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım sürecindeki bileşenlerden bahsedilmektedir. Bunlar teknoloji, sağlık personeli, hasta, sağlık kuruluşları ve sağlıklı bireylerdir. Bu bileşenlerin aktif ve etkin bir organizasyonu ile sağlıkta dijitalleşme başarılı bir uygulamaya dönüştürülebilir.



Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlığın çok daha hızlı ve kaliteli sunulması imkânı vermektedir.

Teknoloji

Teknoloji genel bir bakış açısıyla bir sanat ya da zanaat alanındaki sistematik çalışma olarak tanımlanabileceği gibi geniş anlamıyla belli amaçlar doğrultusunda bilginin bilime uygulanmasıdır (Erdal, 2008). Dolayısıyla teknoloji, bilginin sistematik ve düzenli hale gelerek yeni bir ürüne dönüşmesi olarak tanımlanabilir.

Teknoloji insanlığın doğaya karşı yürüttüğü güç mücadelesinin bir sonucudur. Bu nedenle insanların hayatını kolaylaştıran bir üretilerdir. Ancak teknoloji insan hayatına kattığı değerler yanında çevreye verdiği zararlar gibi sonuçları da söz konusudur. Tarihsel süreç içerisinde teknoloji taraftarı ya da karşıtı olarak çeşitli tartışmalar yapılmıştır.

Teknolojinin olumlu etkilerinden biri sağlık hizmeti sunum sürecine sağladığı katkılardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlığın çok daha hızlı ve kaliteli sunulması imkânı vermektedir. Kullanıcının da içerik üretebildiği web 2.0 teknolojisiyle sağlık hizmetlerine ve sağlığın geliştirilmesi politikalarına katılım imkânı doğmaktadır. Bireylerin aynı mekânda ve aynı zamanda olmadan sağlık hizmet süreçleriyle ilgili işlem yapabilmesi, sağlık kurumunun sahip olduğu ve hedef kitlelerinin kullanımına sunduğu teknolojiyle dayalıdır. Dolayısıyla sağlık hizmetinde hız, kalite, şeffaflık, sağlıklı yaşama dönük tutum ve davranış ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturma gibi faydaları olan sağlıktaki dijitalleşmesinin temel bileşeni, dijital bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Sağlık personeli

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin bir diğer bileşeni, *dijital teknolojiyi kullanacak ya da bu teknolojinin hastalar tarafından kullanılması sonucunda gelişebilecek hasta odaklı sağlık hizmeti sunum sürecini benimseyerek içselleştirmesi gereken sağlık personelidir*. Bu bakımdan sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin sağlanabilmesi için verilerin dijital ortama girilmesinde ya da aktarılmasında bu teknolojiyi kullanabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerektirdiği hızlı hizmet süreçlerine yansıtılabilen, hasta ve hasta olmaya aday diğer vatandaşların ürettiği içeriklerin zamanlı olarak takibini sorumlulukla üstlenebilecek sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır.

Sağlık personeli denildiğinde hasta iletişimi açısından en önemli grubun hekimler olduğu söylenebilir. Teknolojinin hekim-hasta iletişiminde artı ve eksilere neden olabileceği tartışılmaktadır. Hekimin kimliğini belirleyen, sahip olduğu bilgi ve hastasıyla kurduğu iletişimidir. Günümüzün hekim kimliği tedavi konusunda

hastayla eşit bir sorumluluğu paylaşan ve öğretici bir kimliktir. Bu bakımdan teknolojinin hekimi hastadan uzaklaştırdığı ve klinik ortamının yabancılaşmaya neden olduğu dile getirilmektedir. Ancak bunun bir seçim sorunu olduğu söylenebilir. Çünkü aynı teknoloji, hekime hastayla insanca ilişki kurmasına olanak sağlayacak zamanı da kazandırmaktadır (Oğuz, 1995).

Hastalar

Dijital sağlık hizmetlerinin öncelikli tüketicisi hastalardır. Sağlıktaki dijitalleşmenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hastaların dijital ortamdaki randevu sistemini kullanabilmesi, laboratuvar sonuçlarını görebilmesi ya da sağlık hizmetiyle ilgili dijital ortamdaki diğer işlemleri yapabilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle hastalar bu teknolojiye ulaşabiliyor ve bunu kullanabiliyor olmalıdır. Diğer bir ifadeyle hastaların dijital sağlık sistemlerini kullanabilecek becerileri kazanması gerekir. Bu becerilerin kazanılması, kurulan dijital sağlık sisteminin kolay ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara tanıtılması kadar, kişinin günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisiyle de ilgilidir. Dolayısıyla hastaların bu teknolojiye ulaşabiliyor olmasının anlamı, sadece teknik ve maddi olarak o teknolojiye sahip olmak değil aynı zamanda onu kullanabilecek bir demografik niteliğe de sahip olmak demektir.

Sağlık kuruluşları

Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi, sağlıkla ilgili bilgi ve belgelerin ya da herhangi bir hizmet için başvuru formu gibi dokümanların dijital ortama aktarılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla dijitalleşme sürecinin bir bileşeni de bu hizmetleri sağlayıcı kurumlardır. Yöneten ya da koordinatör sağlık kurumundan sağlık hizmeti üreten en alt birimlere kadar bu dijitalleşmenin sağlanması gerekmektedir. Kurumsal olarak bu birimler dijital süreçleri benimseyen politikalar geliştirmeli ve bu sistemleri kurarak işletmelidir.

Sağlıklı bireyler

Dijital sağlığın öncelikli hedeflerinden biri sağlıklı bireylerdir. Sağlığın geliştirilmesi kavramı bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla sağlığın geliştirilmesiyle hedeflenen sağlıklı bir toplum yapısının önemli bileşenlerinden biri, sağlıklı bireylerin dijital sistemi aktif olarak kullanıyor olmasıdır. Sağlığın geliştirilmesi politikaları, sağlıklı bir toplum oluşturma adına hastalığa yakalanmadan önce önlem alabilmek için sağlıklı bireylerde bir bilinç oluşturma hedefini taşımaktadır. Dolayısıyla *dijital alana taşınan sağlıkla ilgili bilgi ve belgelere ulaşılması konusunda toplumun genelinde bir duyarlılığın gelişmesi gerekir.*

SAĞLIK İLETİŞİM ARACI OLARAK “SOSYAL MEDYA”

Bireylerin kendilerini sağlıkla ilgili birçok bilgi ve uygulama konusunda sürekli ve yoğun baskı altında hissetmesi, hangi uygulamanın doğru ya da hangisinin kendisine uygun olduğunu bilememesi, sağlık alanının geniş ve karmaşık bir alan olması ve bir toplumda herkesin sağlık konusunda topluca bir denge ve refah içinde olmasının arzu edilmesi gibi nedenlerle 1070’lerde sağlık



Sağlığın dijitalleşmesinde başarıya ulaşmak için hastaların dijital randevu sistemini kullanabilmesi, laboratuvar sonuçlarını görebilmesi ya da diğer sağlık işlemlerini yapabilmesi gerekmektedir.

iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır. İlk olarak ABD’de başlayan bu gelişme daha sonra Avrupa’ya yayılmıştır. Sağlık iletişimi kavramı iletişim ve sağlık arasındaki ara yüzü temsil etmektedir. Sağlık iletişiminin en belirgin uygulama alanlarını ise sağlığın geliştirilmesi ve hastalıktan korunma oluşturmaktadır (Yeşilşerit, 2012; Şengün, 2016).



Sağlık iletişimi bireylerin ve toplumların sağlık konusunda daha fazla yetkilendirilmesi için gittikçe önem kazanan bir araç olmaya devam etmektedir.

Sağlık iletişimi, bireylerin ve nüfusun sağlık durumunu iyileştirmeyi hedeflemektedir. Sağlık iletişimi, eğitici eğlenme (edutainment) veya eğlenceli eğitim (entereducation), sağlık gazeteciliği, kişiler arası iletişim, medya desteği, kurumsal iletişim, risk iletişimi, sosyal iletişim ve sosyal pazarlama dâhil birçok alanı kapsamaktadır. Kitle ve multi-medya iletişiminden, hikâye anlatma, kukla gösterisi ve şarkılar gibi geleneksel ve kültüre özgü iletişime kadar birçok formda olabilir. İletişim araçlarında, özellikle multi-medya ve yeni bilgi teknolojisindeki ilerlemeler sağlık bilgisine erişimi iyileştirmeye devam etmektedir. Bu açıdan, sağlık iletişimi bireylerin ve toplumların daha fazla yetkilendirilmesi için gittikçe önem kazanan bir unsur olmaya devam etmektedir(sbu.saglik.gov.tr).

Bireylerin ve toplumların sağlık konusunda yetkilendirilmesinin en önemli araçları arasında interaktif iletişim imkânı doğuran web 2.0 teknolojisine dayalı internet kullanımıdır. Modern iletişim sisteminin en büyük destekçisi olan internetin 1970’lerde başlayıp 1990’lardan sonra hızla artan kullanıcı sayısı, 2000’li yıllarda sosyal medyanın işlerlik kazanmasıyla her kesimden insanı ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır (Vural ve Bat, 2010).

Geniş kitlelere ulaşma özelliği ile sosyal medya sağlık mesajlarının yayıldığı önemli mecralar arasına girmiştir. Sosyal medyanın, sağlık hizmetleri ve hastaların bilgiye ulaşımında çok önemli roller üstlendiği genel olarak herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Sosyal medya araçları kullanarak, sağlık mesajlarına erişimi genişletmek, katılımı teşvik etmek ve inandırıcı, bilime dayalı paylaşımları artırmak önemli bir konu haline gelmiştir (Şener ve Samur, 2013).

Bireyler aile, akraba ve arkadaş gibi yakın çevreleriyle konuşamadıkları konular hakkında sosyal medyaya kolaylıkla başvurabilmektedirler. Sağlık bilgilerinin mahremiyet özelliği nedeniyle sosyal medya kullanımı daha etkili hale gelmektedir. Bu bakımdan geniş kitleler sosyal medyaya sağlık konusunda bilgi kaynağı olarak başvurmaktadır. Örneğin Amerikalıların yaklaşık yüzde 88’i sağlıkla ilgili konularda internetten arama yapmakta, yüzde 20’si sosyal medya araçlarını kullanmakta ve yüzde 20 içerisindeki her 4 kişiden 1’i gelecekte alacağı sağlık kararlarında sosyal medyanın etkili olacağını düşünmektedir (Tengilimoğlu vd., 2015).

Sağlığın bir sağlık iletişim aracı olarak sosyal medyada temsili arttıkça bireylerin sağlık okuryazarlığı da artmaktadır (Taşkaya, 2018). Bu bakımdan sağlık iletişiminin önemli bir aracı olarak sosyal medya, sağlık personelinin meslektaşları ile bağlantı kurabilmesi, sağlık personelinin hastaları ve toplumu bilgilendirmesi, sağlık hizmeti kapsamının klinik sınırlarının dışına taşınabilmesi (Mendi, 2016), sağlığın geliştirilmesi, kronik hastalıklar yönetimi, sağlık eğitimi, sağlık turizmi (Taşkaya, 2018), sağlık kuruluşları kurumsal iletişimi, sağlık profesyonelleri iletişimi

yönetimi, viral sağlık ve alternatif tıp alanlarında kullanılabilir. Bu alanlar çalışmanın bundan sonraki bölümünde oluşturulan başlıklarla ele alınmaktadır.

Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanım Alanları

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun bütün kesimlerinin ve tüm demografik gruplarının büyük çoğunluğunun ulaşabilir olduğu sosyal medya, sağlık alanında mizahi bir deneyimin paylaşımından son derece teknik bir konunun açıklandığı bilgiye erişime kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Aşağıda sağlık iletişimi açısından sosyal medyanın kullanılabileceği alanlar sıralanmıştır.

Sağlığın geliştirilmesi

Sağlığın geliştirilmesi politikaları toplumun bütün kesimleri adına sağlığın dengelenmesini, her bir toplum ferdinin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve bu anlamda bireylerin sağlıklı bir yaşam için tutum ve davranış geliştirmesini hedefleyen yaklaşımları benimsemektedir. Sağlığın geliştirilmesi toplumun sağlık konusunda teşvik edilmesi ve eğitilmesini içermektedir. Dolayısıyla sağlığın geliştirilmesi programlarının geniş kitlelere hitap etmesi gerekmektedir.

Günümüz sağlık politikalarının temelinde yer alan sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesi teknolojik gelişmeleri takip eden bütüncül bakışın yaşama geçirilmesiyle mümkündür. Bu bakımdan sağlık iletişim faaliyetleri toplumsal düzeyden, birey katımlı ve bireyin kendi sağlığı üzerinde artan sorumluluğuna işaret eden bir yaklaşımla yürütülmelidir (Şengün, 2016).

Hem bireysel katılım ve sorumluluk üstlenme hem de geniş kitlelere ulaşma ve bu kitlelerle etkileşimli bir iletişimi benimsemek bu konuda başvurulacak iletişim aracının niteliklerini de tanımlamaktadır. Bu tanıma uygun önemli mecralardan birinin sosyal medya olduğu söylenebilir. Çünkü sosyal medya, sağlık kuruluşlarının sağlığın geliştirilmesi bağlamında hasta ya da hasta olmayan vatandaşları bilgilendirdikleri araçlardan biridir (Koteyko vd., 2015). Sosyal medya hastalıkların gözlemlenmesinde ve hastalıklara dair verilerin temin edilmesinde yararlı bir araç olabilir (Darı, 2017).

Sağlığın geliştirilmesi politikalarının başarısında katılım konusu kritik bir öneme sahiptir. Özellikle sağlıklı bireylerde sağlıklı yaşam için tutum ve davranışların geliştirilmesi önemli bir sağlık politikasıdır. Katılım hem etkileşimli bilgilendirme hem de sorumlulukların üstlenilmesi nedeniyle etkin bir tutum ve davranış geliştirme yöntemi olabilir. Sağlık hizmetlerinde sosyal medya kullanımı halkın sosyal medya kampanyalarına katılımını, desteğini ve verilen mesajı uygulayabilme becerilerini artırmaktadır (Taşkaya, 2018). Kısaca belirtmek gerekirse sosyal medya, doğrudan katılım, geniş kitlelere ulaşma ve etkileşimli özelliğe sahiptir. Bu yönüyle sağlık iletişimi için yeni fırsatlar sunmaktadır. Sağlık kampanyalarında olumlu sağlık davranışlarını özendirebileceği gibi olumsuz sağlık davranışlarından da uzaklaşılmasını sağlayabilir (Mendi, 2016).

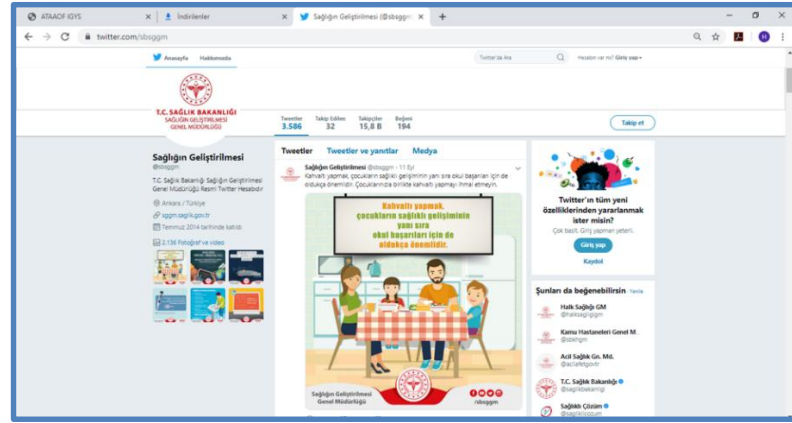


Sosyal medya sağlık kuruluşlarının sağlığın geliştirilmesi bağlamında hasta ya da hasta olmayan vatandaşları bilgilendirdikleri araçlardan biridir.



Örnek

- Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminin başında hem Facebook hesabından hem de Twitter hesabından paylaştığı bir çekirdek aile figürüyle şu mesajı paylaşmıştır: "Kahvaltı yapmak çocukların sağlıklı gelişmesinin yanı sıra okul başarıları için de oldukça önemlidir."
- Facebook ve Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü sağlıklı bir toplum oluşturma adına önemli tarihlerde ve diğer zamanlarda çeşitli mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır (Bkz. Görsel 10.1).



Görsel 10.1. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Twitter Paylaşımı



Yönetilemediğinde hurafe bilgilerle dolabilecek olan sosyal medya, kronik hastalıkların yönetimi konusunda ilgili kurum ve kişiler tarafından etkin bir şekilde yönetilmelidir.

Kronik hastalıklar yönetimi

Kalp ve damar hastalıkları, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklar kronik hastalıklar olarak tanımlanabilir. Bu hastalıklar dünyadaki ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin 2008 yılında Dünya'daki toplam 57 milyon ölümün yüzde 63'ü kronik hastalıklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de de kronik hastalıklarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2011 yılında, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı kurulmuş ve bu başkanlığa bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla ilgili plan ve programların hazırlanması ve yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkların kazandırılması gibi görevler verilmiştir.

Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla mücadele başlığı altında yapılacak kampanya ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarında sosyal medya önemli bir araç olarak kullanılabilir. Çünkü sosyal medya ve internette en çok taranan terimler arasında tarama yapan kişiyi ya da akrabalarını etkileyen kronik hastalıklar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar kronik hastalığı olan bireylerin hastalığıyla ilgili bilgileri sıklıkla sosyal medya platformlarından edindiğini ortaya koymaktadır (Akt. Taşkaya, 2018). Bu bakımdan boşluk bırakıldığında bilimsel olmayan gerçek dışı

bilgilerle dolabilecek olan sosyal medya ortamının kronik hastalıkların yönetimi sürecinde ilgili kurum ve kişiler tarafından etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Sağlık kuruluşları kurumsal iletişimi



Sosyal medya, sağlık kuruluşları için önemli bir bilgilendirme, duyurum, haber olma ve geri bildirim aracıdır.

Sosyal medya kamu ya da özel sağlık kuruluşlarının kurumsal iletişim yönetiminde kullanabilecekleri önemli bir kitle iletişim aracıdır. Kullanıcılarına etkileşimli bir iletişim ortamı sağlayan sosyal medya, bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere olan güvenini artırabilmektedir. Ayrıca bireylerin sağlıkla ilgili bilgi taramalarında sıklıkla başvurdukları mecralardan biridir. Bu bakımdan sağlık kuruluşları gerek bilgilendirme, gerek duyurum, gerek haber olma ve gerekse hasta olsun ya da olmasın toplumun bütün kesimlerinden geri bildirim alabilmesi için sosyal medyayı etkin bir araç olarak kullanılabilir.

Sosyal medya sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti süreç yönetiminde göz ardı etmemesi gereken bir alan olarak değerlendirilebilir. Çünkü bireyler sağlık hizmeti tercihini yaparken sosyal medya paylaşımlarından etkilenmektedirler. Yapılan bir araştırmada *sosyal medyayı kullanan bireylerin çok büyük bir bölümünün hastane tercihiinde sosyal medyaya başvurduğu ve hem hastane tercihi öncesindeki hem de sağlık hizmeti alımı sonrasında sosyal medya kullanma eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür* (Çimen vd.2015). Dolayısıyla bireyler hem sağlık hizmeti alacağı sağlık kuruluşunun seçimini yaparken hem de hizmet alımı sonrasında konuyla ilgili olarak sosyal medyaya başvurmaya devam etmektedir.

Sağlık profesyonelleri iletişim yönetimi

Sağlık kuruluşlarının yöneticileri ya da bu kuruluşlarda görev yapan doktorlar, bireysel sosyal medya hesaplarını mesleki kariyerlerinin iletişim yönetimi aracı olarak kullanabilmektedirler. Ancak bu durumun genellikle özel sağlık kuruluşlarının yöneticileri ya da doktorları için geçerli olduğu söylenebilir. Bu şahsi hesaplarda özel yaşamlarıyla ilgili paylaşımlara yer vermeyerek mesleki deneyimlerini, mesleki ilişkilerini, mesleki başarılarını ve mesleki toplantılarını ya da uzmanlık alanıyla ilgili sağlık bilgilerini paylaşabilmektedirler. Dolayısıyla sosyal medya sağlık profesyonellerinin mesleki anlamda bireysel imaj ve itibar değerlerinin yönetildiği bir mecraya dönüşebilmektedir.

Sağlık personelleri arası iletişim

Sosyal medya, sağlık personelleri arasında mesleki ve sosyal bağlamda iletişim kurdukları mecralar olarak kullanılabilir. *Sosyal medya aracılığıyla sağlık uzmanlarının birbirleriyle görüş ve bilgi paylaşımları kolaylaşmaktadır*. Örneğin hekimlerin birbirleriyle deneyimlerini paylaştıkları ve yalnızca hekimlerin üye olabildiği Sermo, Doximity ve QuantiaMD gibi sosyal ağlar oluşturulabilir (Mendi, 2015).

Doktor-hasta iletişimi

Doktor-hasta iletişiminin karşılıklı iyi ilişkilerin kurulması, bilgi transferi ve tedaviyle ilgili karar verme gibi amaçları vardır. Günümüz doktor-hasta iletişimi karar verme sürecinde hasta ve doktor arasında bir ortaklığın kurulmasını



Sosyal medya katılımcı bir yolla hastaların sağlıkla ilgili bilgileri dolaysız ve aracısız olarak güvendikleri doktorlardan alabilecekleri mecralardır.

gerektirmektedir. Çünkü sağlıktaki değişim, hasta hakları ve eğitim seviyesinin artması gibi faktörler hastanın tıbbi karara katılmasının önemini artırmaktadır (Özçakır, 2004). Doktorların hastalarıyla iletişim kurdukları bir platform olan sosyal medya (Koteyko vd. 2015), katılımcı bir yolla hastaların sağlıkla ilgili bilgileri dolaysız ve aracısız olarak güvencikleri doktorlardan alma imkânı buldukları ve hasta doktor ilişkisinin güçlendiği bir mecraadır (Darı, 2017).

Sağlık hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerince daha ulaşılır hale gelmesi daha fazla insanı sağlık hizmeti talep eder duruma getirmiştir. Bu ortam, toplumun farklı sosyo-demografik gruplarına hitap edecek sağlık hizmetleri pazarını oluşturmaktadır. Doktor ve hasta arasındaki iletişimde bilginin kaynağı olması nedeniyle doktorlar daha etkin görünse de bu pazarda ortaya çıkan rekabet, doktor ve hasta arasında eşitler arası bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Bu durum hastanın daha fazla ve daha ayrıntılı bilgiyi doktordan talep etmesine neden olmaktadır. Doktorların hastalar tarafından seçilebiliyor olması, doktorun uzmanlık alanıyla ilgili bilgisinden çok, hastalarıyla kurduğu iletişimin tercih ediliyor olmasına neden olmuştur. Bu bakımdan doktorların hastalarıyla iletişiminin diyaloga dayalı bir şekilde oluşmasını kolaylaştıracak olan sosyal medyanın doktor-hasta iletişimde kullanılması önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak burada doktorların güvenilir bilgi ve mahremiyet konusuna özen göstermesi gerekmektedir.

Sağlık eğitimi

Günümüz sağlık sistemindeki değişimler sağlık bakımı ve yapısını değiştirmektedir. Hastaların hastanede yatış süreleri kısaltmakta ve tedavinin devamı olarak hastane sonrasındaki süreçte hastanın yaşam biçiminde önemli değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler sağlıklı ya da hasta bireyin, ailesinin ve yakınlarının gerekli sağlık eğitimi alması gereğini doğurmakta ve bu eğitimin sistematik bir şekilde yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır (Kaya, 2009). Hastanın bakımının nasıl olacağı, nasıl yiyip içeceği, egzersizlerini nasıl yapacağı, hijyen konusunu nasıl yerine getireceği, olası sorunların neler olabileceği, ilaçlarını nasıl kullanacağı gibi birçok sorunun cevabına bu süreçte ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla zaman ve mekân sınırlaması olmadan iki yönlü iletişim kurma imkânıyla bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda ulaşma imkânı veren sosyal medya bu süreçte etkin bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca tedavi sürecinde teknolojik cihazların kullanımıyla ilgili bir eğitimin de sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla yapılabileceği söylenebilir.

Sağlık turizmi

İnsanların ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi almayı amaçlamaları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. Sağlık turizminin hedef kitlesi hem sağlığı bozulmuş olan kişileri hem de sağlığını korumaya duyarlı kişileri kapsamaktadır (Aydın, 2012). Ayrıca sağlık turizmi tıbbi tedavinin yanında medikal turizmi, termal turizmi, engelli turizmi ile yaşlı turizmi de kapsamaktadır (www.saglikturizmi.gov.tr). Dolayısıyla sağlığını kaybetmiş insanlar kadar sağlıklı insanlar da sağlık turizminin temel hedef kitleleridir.



Kurumsal bir içerik üretiminin zorunlu olmadığı sosyal medya, başka şehir ya da ülkelerle ilgili ham bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

İletişim teknolojileri gerek dünyanın farklı yerlerinde ikamet eden turistlere ulaşmak ve gerekse onların değerlendirmelerini almak ve güven oluşturmak için sağlık turizmine önemli fırsatlar sunmaktadır (Öksüz ve Altıntaş, 2017). Güven oluşturabilmenin temel bir koşulu olarak, sağlık turistlerinin değerlendirmelerini alabilmenin gereği olan iki yönlü iletişim bu fırsatların başında gelmektedir. Bu bakımdan sosyal medya sağlık turizmi için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bireyler başka bir şehirde ya da ülkede alacakları sağlık hizmetiyle ilgili detaylı bilgiye çoğunlukla internetten ya da sosyal medyadan ulaşmaktadır.

Gazete, televizyon gibi diğer yaygın kitle iletişim araçları internete göre hem daha pahalı hem de zaman ve mekân açısından ulaşılabilir olmayı daha da sınırlandırmaktadır. Ayrıca iletişim sürecini kontrol etme gibi bir fırsatı kullanıcıya vermektedir. Kontrolün büyük ölçüde alıcıda olduğu internet ortamında her an istenilen bilgiye ulaşılabilir olması, sağlık turizmi için interneti ve sosyal ağları güçlü bir araç haline getirmektedir.

Kurumsal bir içerik üretiminin zorunlu olmadığı sosyal medya, başka şehir ya da ülkelerle ilgili ham bilgiye ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Çünkü burada üretilen içeriklerin çoğunluğu kullanıcılar tarafından oluşturulduğu için reklam, halkla ilişkiler ya da propaganda amaçlı bir mesaj üretim sürecinden geçmemektedir. Aynı sağlık turizmi alanıyla ilgili çok sayıda kaynak tarafından bilgi üretilmekte ve çoğunlukla bu kaynaklar bu hizmetlerden daha önce yararlanmışlardır. Bu bakımdan internet ve sosyal medya mecraları sağlık turizmi alanında daha güvenilir bilgi kaynaklarına dönüştürmektedir.

Viral sağlık

Ağızdan ağıza pazarlamanın bir alt alanı olarak tanımlanabilecek viral pazarlama bilgilerin bir virüs gibi yayılmasını içermektedir. Tüketici konumundaki kişi, ürünle ilgili olduğunu düşündüğü kişilere ürünle ilgili bilgileri iletmektedir. Yani bir ürünle ilgili bilgiler tüketiciler tarafından diğer gönüllü alıcılara iletilmekte ve böylece bilgiler sürekli bir yayılım göstermektedir. İnternet ve sosyal medya bu bilgi akışı açısından önemli bir araçtır.

Viral pazarlama kavramından hareketle “viral sağlık” başlığıyla bir kavram üretilir. Çünkü *sosyal medya mecralarında hastalar ya da sağlıklı kişiler tarafından sağlıkla ilgili bilgiler ağızdan ağıza yayılmaktadır. Etkileşimli bir iletişim sistemine sahip olması nedeniyle sosyal medya gönüllü kişiler arasında sağlıkla ilgili bilgilerin yayılmasına neden olmaktadır.* Dolayısıyla bir sağlık iletişim alanı olarak viral yolla yayılan sağlık bilgilerini yönetmek gerekmektedir. Çünkü Sosyal medya sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin alındığı ve çoğaltıldığı bir mecraya dönüşebilmektedir (Koteyko vd. 2015).

Bireyler hastane ve hekimlerle ilgili yorumları okumak, benzer hastalıklara yakalanan kişilerin paylaşımlarını ve başarı hikâyelerini takip etmek ve yakalandıkları hastalıklarla ilgili doktorlarla iletişime geçebilmek amacıyla sosyal medyayı kullanabilmektedirler. Bu amaçların gerçekleşmesinde sosyal medya dijital arkadaş etkisiyle bireylerin sektör temsilcileriyle ilgili fikir edinmesini sağlamakta ve kararlarını etkilemektedir (Tosyalı ve Sütçü, 2016).



Sosyal medya sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin alındığı ve çoğaltıldığı bir mecraya dönüşebilmektedir.

Alternatif tıp

Alternatif tıp, bireylerin hasta olduklarında ya da sağlıklı iken modern tıbbın dışında başvurdukları tedavi ya da önleyici yöntemlerden biri olarak ifade edilebilir. İnsanlar, hasta olduğunda ve bu hastalığına modern tıbbın bir çözüm getiremediğinde hastalığına çare aramak için bilimsel olarak doğruluğu kesinleşmemiş ancak tedavi edici olduğuna inanılan yöntemlere başvurmaktadır. Ayrıca insanlar, çevrelerinden ya da duydukları hikâyelerden etkilenerek sağlıklarını korumak için çoğunlukla bitkilerden oluşan ilaç ya da diğer ürünleri deneyebilmektedirler.

İnternet mecraları ve özellikle sosyal medya, sağlıkla ilgili bilgilerin en karmaşık şekilde yayıldığı alanlardan biridir. Bu bilgiler içerisinde alternatif tıp olarak nitelendirilebilecek bitkilerin ya da bitki kaynaklı ürünlerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasını taşıyan bilgiler sıklıkla yer almaktadır. Bilimsel doğruluğu kanıtlanmış bilgilerle hareket eden modern tıbbın yetersiz olduğu durumlar ve bunların hikâyeleri alternatif tıpla ilgili bilgilerin insanlar tarafından daha güvenilir görülmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla sağlık iletişimi açısından sosyal medya mecrası alternatif tıpla ilgili bilgilerin yönetilmesi gereken bir alandır. Bu konuda bir duyarlılık ve bilinç oluşturulması ve insanların doğru bir şekilde yönlendirilebilmesi için internet ve özellikle sosyal medya mecralarının sağlık iletişimi açısından göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Sosyal Medyanın Sağlık Hizmetlerinde Kullanılma Riskleri

Sosyal medyanın sağlık hizmetleri alanında kullanılması sağlık iletişimi açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak bazı risklere de neden olabilmektedir. Bu riskler sağlık personelinin maruz kalacağı sorunlar olabileceği gibi meslekle ilgili olumsuzluklar da olabilmektedir. Bununla birlikte gerek hastaların tedavi süreçleriyle ilgili ve gerekse toplumun genel sağlığı ile ilgili risklere de neden olabilmektedir.



Sosyal medya sağlık personeli, mesleki olumsuzluk, hastanın tedavi süreci ve toplum sağlığı açısından riskler taşıyabilmektedir.

Sağlık personelinin karşılaşılabileceği riskler: Sağlık hizmetlerinde sosyal medya kullanımı sağlık çalışanlarının sorumluluk, gizlilik, disiplin ve hukuki sorunlara maruz kalma olasılığını artırmaktadır (Taşkaya, 2018). Sosyal medya mecralarında sağlık çalışanları tarafından paylaşılan her bir bilgi, sağlık çalışanı açısından sorumluluk gerektiren bir konudur. Paylaşılan bir bilgi, hem hukuki açıdan hem de vicdani açıdan sağlık personelinin sorumlu davranmasını zorunlu kılmaktadır. Tıbbi bir bilginin doğru anlaşılması için yeterince açık olmaması hastaların yanlış yönlendirilmesine neden olabilir. Ayrıca sosyal medyada sağlık personelinin paylaşımları, hem görevi hem de bulunduğu pozisyonu açısından disiplin soruşturmasına konu olabilir. Gerek kurumsal bilginin ve gerekse hasta bilgilerinin gizliliği konusunda sınırların kesin olarak çizilememesi ya da bu alandaki farklı yorumlar sağlık personelinin hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabilmektedir.

Yanlış bilgilerin yayılması: Modern tıbbın doğrulamadığı ya da alternatif tıp uzmanlarınca onaylanmayan bilgiler sosyal medya mecralarında yayılabilmektedir. Sosyal medyada paylaşımlarıyla içerik üreten kullanıcılar her zaman uzmanlık

bilgisi olanlar değildir. Sağlıkla ilgili deneyimlerini paylaşanlardan çevresinden edindiği duyumlarından hareketle bilgi üretenlere kadar geniş bir çerçevede paylaşımlar yapılabilmektedir. Bu da çoğunlukla sağlık bilgisinin doğruluğu açısından risklere neden olmaktadır.

Kişinin hastalığına dönük bilgiye ulaşma riski: Sağlık alanında üretilen bilimsel bilgiler zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Geçmişte doğru olarak kabul edilen bir bilgi, bugün yanlışlanabilmektedir ya da sağlıklı bir bireyi tanımlayan tıbbi değerlerde değişimler olabilmektedir. Bu durum sağlıkla ilgili bilgilerin karmaşıklaşmasına, hasta için hangi bilginin doğru olduğu kararının zorlaşmasına neden olmaktadır. Hasta tedavi süreci ya da toplum sağlığının geliştirilmesiyle ilgili kararların alınması sürecine hastanın ya da sağlıklı bireylerin katılımı önemlidir. Ancak bu kararların sağlık uzmanlarının rehberliğinde alınması gerekmektedir. Pratikte ise insanlar, genellikle sağlık problemiyle ilgili belirtiler rahatsız edici boyuta ulaşmadan önce herhangi bir sağlık kuruluşu ya da sağlık uzmanına danışmadan internete ya da sosyal medyaya başvurumaktadırlar. Bu da insanların sağlık durumuyla ilgili doğru bilgiye ya da tedavi kararına ulaşmasını güçleştirmektedir.

Modern sağlık yöntem ve uygulayıcılarına güven kaybı: Modern tıbbi yöntemlerle sağlık sorununa çözüm üretilemediği durumlarda bireyler, bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmamış tedavi yöntemlerine yönelebilmektedir. Modern tıp adına olumsuz, modern tıbbin desteklemediği uygulamalar adına olumlu olan bu deneyimlerin sosyal medyada paylaşılması modern sağlık yöntem ve uygulayıcılarına olan güven kaybı riskini doğurmaktadır.

Mahremiyetin korunamaması: Sağlık hizmetlerinde sağlık personeli ile hasta arasında gerçekleşen iletişimin en önemli unsurlarından biri hasta mahremiyetinin korunmasıdır. Ancak sosyo-demografik ve kültürel farklılıklar nedeniyle mahremiyetin sınırlarının gerek sağlık personeline ve gerekse hasta ve yakınlarınca ortak bir çerçevede oluşturulmaması ciddi iletişim sorunlarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde sağlık personelleri tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları bu anlamda risklerle karşı karşıyadır.

Toplumun sağlığını tehlikeye atacak tutum ve davranışların gelişmesi: Hekime başvuracak kadar hastalık algısı taşımayan ancak günlük yaşamında sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu düşünen bireylerin internet ortamında edindiği yanlış bilgiler toplum sağlığı açısından riskler oluşturmaktadır. Çünkü bireyler sağlıklı yaşamak adına gerek olmadığı halde çeşitli yöntemlere başvurabilmekte ve bunları gerçek ve sanal çevresine aktarabilmektedir. Bu da hem kendi hem de başkalarının sağlığı açısından risklere neden olabilmektedir.

İletişim Krizi Riskleri: Toplu yaşamın olduğu mekânlarda zehirlenme, enfeksiyon, düşme, çarpma gibi münferit olarak yaşanabilecek vakaların sosyal medyada paylaşılması, olayı toplum sağlığını ilgilendiren bir boyuta taşıyabilmekte ve sağlığı koordine eden kuruluşların sağlık iletişimi yönetiminde krizlere neden olabilmektedir. Örneğin yurttan kalan bir öğrencinin kişisel bir nedene bağlı olarak



Sosyo-demografik ve kültürel farklılıklar nedeniyle mahremiyet sınırlarının sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları açısından ortak bir zeminde oluşturulması zorlaşmaktadır.

zehirlenmesinin sosyal medyada paylaşılması, zehirlenmenin öğrencilerin yurt yemekhanesinde yediği yemekten kaynaklandığı gibi bir algıya neden olabilir. Bu da bireysel bir vakanın yurttaki kalan tüm öğrencileri ilgilendiren bir vakaya dönüşmesini sağlayabilir. Dolayısıyla bu durum, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yönetilmesi gereken bir iletişim krizidir.

Sağlıkta Sosyal Medya Kullanım Etiği

Sosyal medya sağlık iletişimi açısından sağladığı faydalar kadar riskleri de barındıran bir mecralardır. Bu nedenle sosyal medyanın sağlık iletişiminde kullanılmasında bazı etik ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu ilkeler çoğunlukla sağlık personelinin uyması gereken etik kuralları kapsamaktadır. Sağlık personelinin uyması gereken bu kurallar şunlardır (akt. Taşkaya, 2018):

- Belirli bir hasta hakkında konuşmaktan kaçınılmalı,
- Hasta olmayanlara tıbbi bir tavsiyede bulunmaktan kaçınılmalı,
- Hasta mahremiyeti ve gizliliğine önem verilmeli,
- Yazılan tüm içeriğin keşfedileceği unutulmamalı,
- Hastalara arkadaşlık isteği gönderilmemeli,
- Hastalardan gelen arkadaşlık isteklerini mesleki sosyal ağ sayfalarına yönlendirilmeli,
- Sağlık çalışanı mesleki sosyal ağlara doğru kimlik bilgisiyle üye olmalı.



Bireysel Etkinlik

- Bir devlet bir de özel hastane seçerek personel listesinde bulunan doktorlara herhangi bir sağlık sorunuyla ilgili bilgi talep eden mesaj göndererek yapılan geri dönüşleri rapor ediniz.
- Bir sosyal medya mecrasında herhangi bir sağlık sorunuyla ilgili bilgi isteyen paylaşımda bulunduktan sonra bu paylaşımın yorumları rapor ediniz ve ilgili sağlık sorununun tıbbi tedavi bilgisi ile karşılaştırınız.



Özet

- Teknoloji bir taraftan insanın günlük hayattaki zayıflıklarına bir çare iken diğer taraftan konforunu artıran bir unsurdur. İnsanın günlük yaşamında hem zayıflıklarının üstesinden gelmeye hem de konforunu artırmaya çalıştığı alanlardan biri de sağlıktır. Sağlığın dijitalleşmesi bireyin sağlık konusunda zayıflıklarının üstesinden gelmesi ve sağlıklı yaşam adına konforunun artması için avantaj sağlayan bir gelişme olmuştur.
- Sağlıkta dijitalleşme, hem tedavi araç ve yöntemleriyle hem de bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili bir süreçtir. Hastalıkların tedavi edilmesinde ve sağlıklı yaşamın korunmasında teknolojinin gelişmesi inceleme, teşhis ve tedavi yöntemlerinin dijital araçlarla yapılmasını sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri ise sağlık hizmetlerinin yönetiminden sağlık personelleri arası iletişime; doktor hasta iletişiminden hastalar arasındaki etkileşime; hastalıkların tedavi edilmesinden sağlığın geliştirilmesi konusuna kadar geniş bir alanı etkilemektedir.
- Etkin ve verimli bir sağlık hizmeti verebilmenin temel koşullarından biri bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi yeni bir sağlık hizmeti örgütlenmesine ihtiyacı artırmıştır. Günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri bu ihtiyacın sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi olduğunu göstermektedir. Sağlık hizmetinde dijitalleşme verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması sürecinde sağlık bilgi sistemlerine odaklanmayı gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi karar destek süreçlerine katılım açısından sağlıkla ilgili kurumların eşgüdümünü kolaylaştırmaktadır. Ancak dijitalleşmenin daha görünür faydası vatandaşların sağlık bilgilerine erişimini kolaylaştırmış olmasıdır. Ayrıca sağlığın dijitalleşmesi, sağlık personeli verimliliğini artırmaktadır.
- Sağlıkta dijitalleşme sağlık hizmetlerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında ele alındığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım aşamasında dikkate alınması gereken unsurlar dijital sağlığın bileşenleri olarak ele alınabilir. Bu bileşenler; teknoloji, sağlık personeli, hasta, sağlık kuruluşları ve sağlıklı bireyler olarak sayılabilir. Bu bileşenlerin aktif ve etkin bir organizasyonu sağlıkta dijitalleşmeyi başarılı bir uygulamaya dönüştürülebilir. Hastaların ve sağlıklı bireylerin sağlık hizmetleri sürecine katılımı sağlıkta dijitalleşmenin önemli bir ayağıdır. Bu katılım internet teknolojisinin sağladığı uygulamalarla kolaylaşmaktadır.
- 1970'li yıllarda ABD'de ilk uygulamaları başlayan daha sonra Avrupa'ya yayılan sağlık iletişimi çalışmaları, geldiği nokta itibarıyla bireylerin ve toplumların sağlık hizmeti sürecinde daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bireylerin ve toplumların sağlık konusunda yetkilendirilmesinin en önemli araçlarından biri ise interaktif iletişim imkanı doğuran web 2.0 teknolojisidir. Web 2.0'ın önemli uygulamalarından biri de sosyal medyadır. Geniş kitlelere ulaşma özelliğine sahip sosyal medya, sağlıkla ilgili mesajların yayıldığı önemli mecralar arasına girmiştir. Sosyal medyanın, sağlık hizmetleri ve hastaların bilgiye ulaşımında çok önemli roller üstlendiği genel olarak herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Sosyal medya araçları kullanarak, sağlık mesajlarına erişimi genişletmek, katılımı teşvik etmek ve inandırıcı, bilime dayalı paylaşımları artırmak günümüzün önemli konularından biridir. Çünkü bireyler aile, akraba ve arkadaş gibi yakın çevreleriyle konuşmadıkları konular hakkında sosyal medyaya kolaylıkla başvurabilmektedirler. Sağlık bilgilerinin mahremiyet özelliği nedeniyle sosyal medya kullanımı daha etkili hale gelmektedir.
- Sağlık iletişimiyle ilgili olarak sosyal medya çeşitli amaçlarla çok geniş bir alanda kullanılabilir. Bunlar sağlığın geliştirilmesi, kronik hastalıklar yönetimi, sağlık kuruluşları kurumsal iletişimi, sağlık profesyonellerinin iletişim yönetimi, sağlık personelleri arası iletişim, doktor hasta iletişimi, sağlık eğitimi, sağlık turizmi, viral sağlık ve alternatif tıp olarak sıralanabilir. Dolayısıyla sağlık iletişimi alanında hem sağlığın geliştirilmesi politikaları, hem hastalıklarla mücadele hem de teşhis ve tedavi süreçlerinde sosyal medya uygulamasından etkin bir şekilde yararlanılabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Sağlıkla ilgili yapılan tanımlar kültürden kültüre farklılıklar göstermektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 - a) Yapılan bireysel yorumlar
 - b) Yapılan toplumsal yorumlar
 - c) Yapılan bilimsel yorumlar
 - d) Yapılan ekonomik yorumlar
 - e) Yapılan kültürel yorumlar
2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının yeniliklerin yayılması aşamalarından biri değildir?
 - a) Hazırlık
 - b) Bilgilendirme
 - c) Onaylama
 - d) Karar
 - e) İkna
3. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dijitalleşmenin sağlık sektörüne sağladığı faydalardan biri değildir?
 - a) Kalite ve verimi artırma
 - b) Tasarruf sağlama
 - c) Kronik hastalıkların gerçekleşme oranını düşürme
 - d) Sağlık politikalarının belirlenmesine katkı sağlama
 - e) Sağlığın geliştirilmesini destekleme
4. Belirli amaçlar doğrultusunda bilginin bilime uygulanmasına ne denir?
 - a) Sanat
 - b) Teknoloji
 - c) Bilim
 - d) Araştırma
 - e) Proje
5. Aşağıdakilerden hangisi dijital sağlığın bileşenlerinden biri değildir?
 - a) Teknoloji
 - b) Kronik hastalıklar
 - c) Sağlık personeli
 - d) Hastalar
 - e) Sağlıklı bireyler

6. Toplumun bütün kesimleri adına sağlığın dengelenmesini, her bir toplum ferдинin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve bu anlamda bireylerin sağlıklı bir yaşam için tutum ve davranış geliştirmesini hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
 - a) Kronik hastalıklar yönetimi
 - b) Sağlık kuruluşları kurumsal iletişimi
 - c) Doktor – hasta iletişimi
 - d) Sağlık personelleri arası iletişim
 - e) Sağlığın geliştirilmesi
7. Günümüz doktor-hasta iletişiminde tedavi süreciyle ilgili tıbbi kararın verilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - a) Karar resmi otoritelere aittir.
 - b) Karar doktorlar heyetine aittir.
 - c) Karar sağlık kuruluşuna aittir.
 - d) Hastanın tıbbi karara katılımı gerekir.
 - e) Kararı yalnızca doktor verir.
8. Sosyal medya mecralarında insanların hastane ve hekimlerle ilgili yorumları okuması, başkalarının hastalık ve tedavi süreciyle ilgili paylaştıkları başarı ya da başarısızlık hikâyelerini takip etmesi gibi şekillerde yayılan sağlık bilgileri nasıl tanımlanabilir?
 - a) Sağlık iletişimi
 - b) Alternatif Tıp
 - c) Viral Sağlık
 - d) Sağlık Turizmi
 - e) Doktor-hasta iletişimi
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın sağlık iletişiminde kullanılması sonucunda sağlık personeliyle ilgili doğabilecek risklerden biri değildir?
 - a) Modern sağlığın güven kaybı
 - b) Sorumsuz davranış gösterme
 - c) Disiplin soruşturmasına maruz kalma
 - d) Hukuki bir yaptırımla karşılaşma
 - e) Gizliliği ihmal suçu
10. Sağlık iletişimi kavramı ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
 - a) 1960'lı yıllar
 - b) 1970'li yıllar
 - c) 1980'li yıllar
 - d) 1990'lı yıllar
 - e) 2000 ve sonrası dönem

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.e, 7.d, 8.c, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Avaner, T. ve Fedai, R. (2017). Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: sağlık hizmetlerinde bilgi sistemlerinin kullanılması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22, 1533-1542.
- Avcı, K. ve Avşar, Z. (2014). Sağlık iletişimi ve yeni medya. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, 39, 181-190.
- Aydın, O. (2012). Türkiye’de alternatif bir turizm; sağlık turizmi. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 14(23), 91-96.
- Çınar, İ. (2004). *Sağlığın geliştirilmesine sağlık iletişimi yöntemleri olarak sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkilerin etkisi*. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
- Çiçek, Ş. E. ve Söğüt, N. (2018). Sağlık sektöründe e devlet uygulamalarının etkinliği üzerine bir araştırma: Isparta ili örneği. *Vizyoner Dergisi*, 9(22), 32-59.
- Çimen, M., Çizmeci, E., Deniz, S. ve Erkoç, B. (2015). Hastane tercihinde sosyal medyanın kullanımı. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8 (42), 1203-1209.
- Danayiyen, A., Kıyak, M. ve Ünal, E. (2007). Hastanelerde yeni iletişim teknolojileri kullanımının kurum içi iletişim doyumuna etkisi. *Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi*, 10(1), 32-63.
- Darı, B. (2017). Sosyal medya ve sağlık. *21.Yüzyılda Eğitim Toplum Dergisi*, 6(18), 731-758.
- Erdal, M. (2008). *Teknoloji yönetimi*, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
- Güngör, N. (2011a). *İletişime giriş*, Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Güngör, N. (2011b). *İletişim kuram ve yaklaşımlar*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Kabasakal, E. (2013) *Aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık personelinin sağlığın geliştirilmesi uygulamalarına ilişkin görüşleri*. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
- Kaya, H. (2009). Sağlık hizmetlerinde hasta eğitimi ve hemşirenin sorumlulukları. *Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences*, 1 (1), 19-23.
- Koçak, A. ve Bulduklu, Y. (2010) Sağlık iletişimi: Yaşlıların televizyonda yayınlanan sağlık programlarını izleme motivasyonları. *Selçuk İletişim Dergisi*, 6 (3) 5-17.
- Koteyko, N., Hunt, D. an Gunter, B. (2015). Expectations in the field of the internet and health: ananalysis of claims about social networking sites inclinal literature. *Sociology of Health & Illness*, 37(3), 468–484.

- Kumbasar, B. (2012) *Sağlık iletişiminde mesaj tasarlamada kültürel faktörlerin rolü*. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
- Mendi, B. (2015). Sağlık iletişiminde sosyal medyanın kullanımı: Dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalar. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi*, 11(44), 275-290.
- Mendi, B. (2016). Sağlık eğitiminde sosyal medyanın rolü ve güncel uygulamalar. A. Büyükarıslan ve A. M. Kırık (ed.), *Sosyal Medya içinde (s.231-248)*, Konya: Çizgi Kitabevi.
- Oğuz, N. Y. (1995). Klinik uygulamada hekim-hasta ilişkisi. *Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi*, 2(3), 59-65
- On, B. (2016) *Bir Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlığın geliştirilmesi ile ilgili görüşleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları*. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Öksüz, B. ve Altıntaş, V. (2017). Sağlık turizminde dijital iletişim kanallarının kullanımı. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 14(1), 59-75.
- Özçakır, A. (2004). Hekim-hasta ilişkisi: Karar verme sürecinde hastanın yeri. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi*, 24, 411-415.
- Peker, S. V., Giersbergen, M.Y.V., Biçersoy, G. (2018). Sağlık bilişimi ve Türkiye'de hastanelerin dijitalleşmesi. *Kastamonu Sağlık Akademisi Dergisi*, 3,(3),81-121.
- Rootman, I., Goodstadt, L.P. and Springett, J. (2001). A framework for health promotion evaluation. I. Rootman, M. Goodstadt, B. Hyndman, D. V. McQueen, L. Potvin, J. Springett and E. Ziglio (eds), *Evaluation in Health Promotion Principles and Perspectives in (pp. 78-38)*, Denmark: World Health Organization.
- Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Sözlüğü (2011). Sağlığın Geliştirilmesi, 3 29 Temmuz 2019 Tarihinde <https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20Te%C5%9Fviki%20S%C3%B6zl%C3%BCK.pdf> adresinden erişildi.
- Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Sözlüğü (2011). Sağlık İletişimi, 29 Temmuz 2019 Tarihinde <https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20Te%C5%9Fviki%20S%C3%B6zl%C3%BCK.pdf> adresinden erişildi.
- Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Sözlüğü (2011). Sağlık, 29 Temmuz 2019 Tarihinde <https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20Te%C5%9Fviki%20S%C3%B6zl%C3%BCK.pdf> adresinden erişildi.

- Sağlık Turizmi Nedir? 29 Temmuz 2019 tarihinde <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10944,02pdf.pdf?0> adresinden erişildi.
- Şener, E. ve Samur, M. (2013). Sağlığı geliştirici bir unsur olarak sosyal medya: Facebook'ta sağlık. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2(4), 508-523.
- Şengün, H. (2016). Sağlık hizmetlerinde iletişim yönetimi. *İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi*, 79 (1), 38-42.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. (2004). Türkiye sağlık bilgi sistemi eylem planı. 04.07.2019 tarihinde [https://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik\(16\).pdf](https://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik(16).pdf), adresinden erişildi.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu. (2013). Türkiye’de kronik hastalıklar ve risk faktörleri sıklığı çalışması, 8 Temmuz 2019 tarihinde <https://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf> adresinden erişildi.
- Taşkaya, S. (2018). Dijital kültür: Sağlık hizmetlerinde sosyal medya kullanımı. V. Çakmak ve S. Çavuş (ed.), *Dijital Kültür ve İletişim (203-230)*, Konya: Literatürk.
- Tengilimoğlu, E., Parıltı, N. ve Yar, C. E. (2015), Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği. 10 Temmuz 2019 Tarihinde <https://dergipark.org.tr/download/article-file/287170> adresinden erişildi.
- Tosyalı, H. ve Sütçü, C. S. (2016). Sağlık iletişimde sosyal medya kullanımının bireyler üzerindeki etkileri. *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 3 (2), 3-22.
- Türk Dil Kurum Sözlüğü. Sağlık, 29 Temmuz 2019 tarihinde <http://sozluk.gov.tr/> adresinden erişildi
- Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. *Journal of Yasar University*, 20(5), 3348-3382.
- Yeşilşerit, T. (2012). *Sağlık kültürünün oluşumunda sağlık haberlerinin yeri: sağlık muhabirleri ve İstanbul’da iki farklı sosyoekonomik yapıdaki mahallede yaşayanlarla yapılan araştırma*. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.